CLASE ESPECIAL

MANEJO DEL POLITRAUMATIZADO

DR. MARTÍN VÁSQUEZ

EPIDEMIOLOGÍA DEL TRAUMA

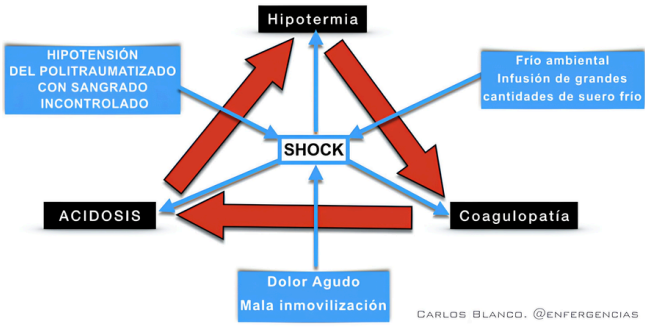
- 3a causa de muerte global; causa principal de mortalidad entre 5-59 años. En Panamá: ~1,600 muertes por trauma al año (~4 cada 2 días). Por cada fallecido, 3 sobreviven con discapacidad permanente.

CENTROS DE TRAUMA Y NIVELES DE ATENCIÓN

- Nivel I: capacidad quirúrgica inmediata 24/7 con todas las subespecialidades. Nivel II-III: capacidad limitada, estabilización y traslado. El triaje prehospitalario decide el destino según la gravedad.

EL DIAMANTE LETAL DEL TRAUMA

- Acidosis metabólica, coagulopatía, hipotermia e hipocalcemia se retroalimentan. La hipocalcemia es por toxicidad del citrato de los hemoderivados, que quela el calcio e inactiva la coagulación y deprime el miocardio.



PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA (PTM)

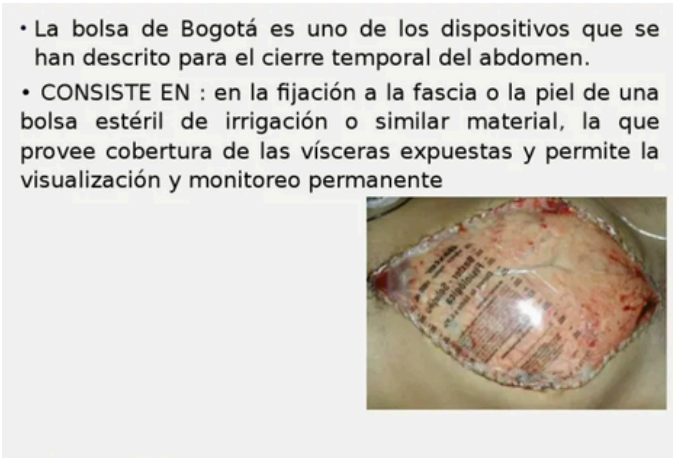
- Proporción balanceada 1:1:1 (glóbulos rojos:plasma:plaquetas) previene coagulopatía dilucional.
- Ácido tranexámico (TXA) 1g IV precoz inhibe la fibrinólisis. Tromboelastografía (TEG) guía la reposición.

REGLA DE ORO EN TAC DE TRAUMA

- TAC de tórax/abdomen/pelvis siempre con contraste IV para detectar extravasación activa (blush) o laceraciones. Única excepción: TAC de cráneo simple en TCE agudo (sin contraste).

TÉCNICA DE CONTROL DE DAÑOS

- Packing hepático/pélvico, control de contaminación entérica sin anastomosis, cierre laparostómico temporal (bolsa de Bogotá), traslado a UCI; reintervención a 24-48h. Mortalidad global: 58%.



MANEJO NO OPERATORIO

- Indicado en lesiones de hígado, bazo, riñón (cerrado) y heridas seleccionadas por arma blanca (25-30% no requiere laparotomía).
- Requiere: estabilidad hemodinámica estricta, sin irritación peritoneal, y disponibilidad 24/7 de cirujano, quirófano, TAC con contraste y radiología intervencionista.